

교육중점트랙 개발 연구 및 적용

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

교육을 담당하는 교수의 역할을 명확하게 하고, 교육에 전념할 시간과 경력 경로를 마련하는 기반 과제입니다. 교수 직무·업적평가 분석을 토대로 두 가지 교육중점트랙과 평가체계, 맞춤형 교수개발 방안을 설계했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

2개 유형 · 교육중점트랙 설계

26개교 · 업적평가 기준 분석

159명 · 52명 · 설문 · 집단면담 자료 분석

9개 · 35개 · 주요 직무 · 세부 교육활동

- 선행 실태조사의 설문 159명·집단면담(FGD) 52명 자료와 국내 26개 의과대학 업적평가 기준을 분석했습니다. 1차년도에 새로 모집한 참여자 수와는 구분됩니다.
- 설문에서 주당 근무시간은 평균 74시간, 적정하다고 인식하는 시간은 58시간이었습니다. 현재 교육활동 비중 19%와 희망 비중 22% 사이의 차이를 확인했습니다.
- 교수의 교육 직무를 9개 주요 직무와 35개 세부 활동으로 구조화했습니다. 강의시수 중심 평가가 충분히 반영하지 못하는 평가도구·교육자료 개발과 역할모델 등의 활동을 확인했습니다.
- 교육중점교수와 의학교육전문교수의 이원 구조를 제안했습니다. 교육중점교수는 기초·임상 교수의 3~5년 단위 전환을, 의학교육전문교수는 대학별 2~4인 확보를 제도 설계안에 담았습니다.
- 교육중심 업적평가체계에 정량·정성 지표를 함께 반영하도록 설계했습니다. 교육 평가 가중치 제안 범위는 기초 교육중점교수 50~70%, 임상 교육중점교수 50~65%, 의학교육전문교수 60~75%입니다.

- 경력·전공·직책·기관의 네 축을 결합한 맞춤형 교수개발 프로그램 맵을 개발했습니다. 교수개발 참여가 교육 수행과 업적 인정으로 이어지도록 연계 구조를 제시했습니다.

- 세 차례 TF 회의를 통해 현황 진단에서 제도 설계로 과제 범위를 구체화하고, 교육책무 관련 정책 제안과 단계별 도입 방향을 정리했습니다. 연구보고서는 총 10장·부록 10종으로 구성했습니다.

1차년도 성과는 실태 분석과 제도 설계안입니다. 신규 임용·시범운영·법령 개정 완료 실적은 포함하지 않습니다. 설문·집단면담은 자발적 참여 자료로 전체 교수를 대표하는 데 한계가 있습니다.

주요 산출물

- 교육중점트랙 제도 도입·교육책무 제도화 연구보고서
- 교육중점트랙 표준 운영모델(안)
- 정량·정성 교육업적 평가지표·가중치(안)
- 맞춤형 교수개발 프로그램 맵
- 교육책무 관련 정책 제안·추진 로드맵
- 트랙 운영 규정 예시·도입 실무 체크리스트

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가

07 · 성과 확산 및 활용 방안

08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1차년도 분석·설계 결과입니다. 국내외 제도 사례는 과제 수행 당시 검토 내용이며, 정책·인사 기준의 변경 제안은 도입 완료 실적과 구분합니다.

1. 추진 배경 및 필요성

가. 의과대학 교육 과업의 변화와 요구

전국 40개 의과대학은 단순 강의 중심 교육에서 벗어나, 다음과 같이 복합적이고 전문화된 교육 과업을 교수자에게 요구받고 있다. 이러한 과업은 개별 교수가 진료·연구의 여유 시간에 부수적으로 수행할 수 있는 성격이 아니며, 전담 인력과 전문성을 전제로 한다.

지역사회 기반 교육 및 장기통합실습(LIC) 운영

학생 맞춤형 진로 설계 및 개별 코칭 제공

e-포트폴리오 기반 평가 설계 및 운영

CPX·OSCE 등 임상수행능력 평가의 개발 및 운영

학생 선발 및 입학전형 평가 고도화

나. 정책·제도적 배경

의과대학을 둘러싼 제도 환경은 최근 수년 사이 급격히 변화하였다. 2024년 「고등교육법 시행령」 제25조 개정으로 의예과·의학과를 통합한 6년제 학제 개편이 추진되면서 교육과정 전면 재설계가 요구되었고, 같은 해 의과대학 정원 확대 정책과 그에 따른 의정 갈등으로 일부 대학은 학년 규모가 2.3배(더블링)에서 2.7배(트리플링)에 이르는 교육 부담에 직면하였다. 코로나19 이후 보편화된 블렌디드 러닝과 생성형 AI의 확산은 교수법과 평가 방식의 재정립을 요구하고 있다.

의과대학 혁신은 국민 건강권과 직결되는 국가 과제이며, 정부의 의대 정원 확대, 대규모 의학교육 인프라 투자, 전임교원 증원 정책은 개별 대학의 자율에만 맡길 수 없는 공공성을 요구한다. 한편 WFME와 KIMEE 등 국내외 평가·인증 기준은 전임교원 확보, 교육역량 강화, 교육업적 평가체계 마련을 핵심 요건으로 명시하고 있고, 영국 GMC는 Medical Act 1983에 근거하여 교육자 선발·전담시간 확보·자원 접근 보장을 기관의 법적 책임으로 규정한다. 그러나 우리나라에는 교육 전담교수제도·교육시간·교육성과 관리를 법으로 규정한 사례가 없다. 교육중점트랙의 제도화는 인증 기준 충족과 평가 우수 대학 육성의 측면에서도 필수 과제이다.

다. 현행 인사·평가제도의 한계

교육중점 역할을 담당하는 교수의 직무·평가·보상 체계가 불명확하여 전문성과 헌신이 실질적으로 인정받기 어렵고, 안정적인 커리어 경로도 부족하다. 대부분의 의과대학 인사제도가 강의 실적 위주에 머물러 실제 교육혁신 실무와 괴리가 있으며, 본업 외에 새로운 교육 업무를 전담하더라도 별도의 경력으로 인정받거나 승진·보상의 변화를 체감하기 어렵다. TF 논의에서 확인된 구조적·문화적 요인은 다음과 같다.

업무 편중: 우리나라 의과대학 교수의 업무 비중은 진료 48.2%, 연구 20.6%, 교육 16.4%로 진료·연구에 편중되어 있다(의료정책연구소, 2012).

평가의 연구 편중: 전국 40개 의과대학 조사에서 재임용·승진 업적평가의 연구업적 반영 비중은 56.8~71.3%로 가장 높았다(양은배 외, 2019). 대학별 업적평가 기준 조사에서도 교육 관련 항목은 극히 미미하거나 아예 없는 경우가 많았다.

평가의 객관화 곤란: 연구업적은 논문 편수·영향력 등 객관화된 등급으로 산출되는 반면, 교육업적은 그에 상응하는 등급 체계가 없어 정량화·객관화가 어렵다.

임상교원의 현실적 제약: 진료 중심 병원 근무 환경에서 임상교원이 3~5년간 교육 중심 역할로 전환하는 것은 「진료 황금기」의 손실로 인식되며, 전임교원보다 임상교원의 급여가 높아 전임 유지가 어려운 구조도 존재한다.

문화적 편견: 「교육중점트랙은 승진용」, 「교육만 하는 교수는 손해본다」는 인식이 트랙 진입을 저해한다.

교육 노동의 비가시성: 교수의 교육 직무는 9개 주요직무·35개 세부활동으로 구성되나, 대부분의 대학에서 강의시수 기반 정량지표로만 환산된다.

라. 교수 인력과 의학교육 조직의 구조적 취약

교육 역할의 확대와 동시에 이를 수행할 인력과 조직의 기반이 약화되고 있다. KAMC DB에 따르면 기생충학·미생물학·병리학·생리학·생화학·약리학·예방의학·해부학을 담당하는 기초의학 교원은 2018년 1,424명(평균 35.6명)에서 2022년 1,277명(평균 31.9명)으로 5년간 147명 감소하였다. 김우미 등(2023)은 향후 5년 이내에 전통적 기초의학 분야 교수 1,316명 중 196명(15%)이 정년퇴임할 예정이며, 신규 임용이 수도권에 집중되어 비수도권의 기초의학 교원 부족이 심각해질 것으로 전망하였다. 후속 세대인 MD 대학원생도 전체의 8%에 불과하여 기초의학 교수 충원은 더욱 어려워질 전망이다.

조직 측면에서도 의학교육을 담당하는 단위의 명칭과 역할이 대학마다 상이하고 불분명하다. 의학교육지원실에 해당하는 조직만 하더라도 교육지원실·의학교육실·교학지원팀·수업지원실·교수학습지원실 등으로 명칭이 제각각이며, 교수개발이나 학생지원 역할을 수행하는 조직이 아예 없는 대학도 있다. 아울러 교수의 약 60%가 하나 이상의 번아웃 증상을 보고하였고, 젊은 교수와 여성 교수의 소진 위험이 상대적으로 높아 교육 역량의 손실이 우려된다.

마. 본 과제가 해결하고자 한 문제(problem statement)

이상의 배경에서 우리나라 의과대학의 교육 트랙 관련 현안은 세 가지로 정리된다. 첫째, 의대교수가 교육에 집중할 수 있는 트랙과 평가 체계가 부족하다. 둘째, 의학교육을 운영하는 의과대학 조직의 역할이 불분명하다. 셋째, 변화하는 교수 트랙에 적합한 교육 전문성이 부족하다.

교육은 모든 교수가 분담하는 「공통 부담」으로 여겨져 왔고, 그 결과 누구의 전문 영역도 아닌 채로 남았다. 교육에 헌신할수록 업적 총점에서 불리해지는 구조가 유지되는 한, 교육과정 개편·평가 고도화·학생지원 강화 등 어떤 혁신 과제도 지속적으로 운영될 인적 동력을 확보할 수 없다. 본 과제는 「교육에 전념하는 교수의 신분·시간·보상을 어떻게 제도적으로 보장할 것인가」를 핵심 문제로 설정하고, 이를 대학 자율에 맡기지 않고 국가 차원의 책무로 전환하는 경로를 설계하는 것을 목표로 하였다.

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
교육중점트랙	교육을 주된 책무로 하는 교원의 경력 경로. 본 연구에서는 교육중점교수 트랙과 의학교육전문교수 트랙의 이원 구조로 정의한다.	본 연구
교육중점교수(Education-Focused Professor)	의과대학을 졸업하고 임상 또는 기초 교원으로 재직하면서 일정 기간(3~5년) 진료·연구 비중을 줄이고 교육에 전념하는 교수. 기초의학 교육자·임상의학 교육자·시니어 교수 등으로 세분화한다.	본 연구
의학교육전문교수(교육전담교수)	교육학·심리상담·통계·의학교육학 등을 전공한 박사학위 소지자로서 교육과정 개발·평가, 교수법 개발, 문항 검토, 학생 멘토링 등 의학교육 전반을 전담하는 교수. MD·non-MD를 모두 포함한다.	본 연구
교육책무성	교육이 개별 대학의 재량이 아니라 국가가 보장하는 책무로 자리 잡도록 하는 제도적 요구. 교육 인력 확보, 전담시간 보장, 교육성과 관리·공개를 포함한다.	본 연구 / GMC Promoting excellence
Protected time(교육 전담시간)	교육 역할 수행을 위해 급여로 보전되는 확보된 업무시간. 미국 LCME는 수치 기준 대신 DCI를 통해 역할별 전담시간과 급여 지원 현황을 보고하도록 요구한다.	LCME DCI Table 4.1-4
Triple Threat Model	한 명의 교수가 교육·연구·진료를 모두 수행하는 전통적 의과대학 교수 모델. 역할 전문화 논의의 대비 개념이다.	의학교육 문헌 일반
Harden & Crosby 12역할	정보제공자·역할모델·촉진자·평가자·계획자·자원개발자의 6개 영역, 12개 세부 역할로 교수의 교육 역할을 유형화한 모형.	Harden & Crosby(2000), AMEE Guide No.20
MEQI	의학교육 질 관리 지표(Medical Education Quality Index). 전국 의과대학의 교육성과를 비교·평가하기 위해 본 연구가 법제화를 제안한 국가 지표 체계.	본 연구
CQI	지속적 질 개선(Continuous Quality Improvement). PDSA 사이클에 기반한 주기적 교육 성과분석·개선 활동.	의학교육 평가인증 기준

용어	정의	출처
Demonstratorship	해부학 등 기초의학 실습 교육을 보조하기 위해 영국·아일랜드에서 운영되는 직책. 의사 면허 취득 후 전문분야 수련 전 단계의 의사가 9~12개월 단기 계약으로 근무한다.	Smith 등(2022)
접촉시간법·상대가치법	교육 활동을 측정하는 두 방법. 접촉시간법(contact-hour method)은 교수와 학습자의 직접 접촉 시간을 기준으로, 상대가치법(relative-value method)은 교육의 난이도·복잡성·책임을 반영하여 기여도를 산정한다.	Mallon & Jones(2002)
AoE / SSA	Harvard 의과대학의 업적평가 요소. Area of Excellence는 학문적 성과·임상 전문성·연구·교육과 교육 리더십의 네 범주 중 주된 업적 영역을, Significant Supporting Activity는 교육특별공로(SME)·행정 및 기관 봉사 등 보조 활동을 평가한다.	Harvard Medical School

3. 선행연구 및 문헌 고찰

가. 문헌 검토 방법 및 범위

PubMed와 RISS를 주 데이터베이스로 하고 수기 검색(hand searching)을 병행하였다. 검색어는 의과대학 교수의 삶·번아웃·직업만족도·업적평가, faculty track, clinician educator, faculty development, work hours/workload, educational accountability 등을 조합하였다. 국내 문헌은 의학교육 관련 학술지와 KAMC·한국의 학교교육평가원의 연구보고서를 중심으로, 국외 문헌은 Academic Medicine·Medical Teacher·JAMA 등에 게재된 교수 트랙·승진제도 연구를 중심으로 검토하였다. 아울러 미국 LCME, 영국 GMC, WFME의 공식 기준 문서와 각 대학의 승진·임용 규정 원문을 직접 확인하였다.

나. 주요 이론·모형

교육자의 질과 교육 성과 — 「교육의 질은 교사의 질을 능가할 수 없다」는 명제가 보여주듯, 교육기관의 성과를 높이는 핵심은 좋은 교육자를 선발하고 효과적인 교육자로 양성하는 데 있다(Barber & Mourshed, 2007). 교육 시스템·환경·교육과정이 갖추어져 있더라도 이를 전달하는 것은 교육자의 역할이다(류지춘·이신동, 2014).

교수진 지원의 정책적 근거 — 카네기 재단의 「Educating Physicians」(2010)는 의학교육 발전과 국민 건강 증진을 위한 조치로 교수진 지원을 제시하며, 의과대학 학장과 교육수련병원장이 재정 지원·멘토링·교수개발·업적 인정 및 승진을 통해 교수의 교육 사명 수행을 뒷받침해야 한다고 강조하였다(Irby 등, 2010).

교수 트랙 이론 — 의과대학은 사명 달성을 위해 서로 다른 주된 역할을 가진 교수를 필요로 하며, 이를 트랙으로 제도화한다(Coleman & Richard, 2011). 미국 98개 의과대학의 평균 트랙 수는 3.6개(1~8개)였고, 이 중 79개교(81%)가 주요 직무 활동을 기준으로 트랙을 정의하여 교수 시간의 50~85%를 교육·연구·진료 중 하나에 집중하도록 설계하였다.

Triple Threat Model에서 역할 전문화로의 전환 — 한 명의 교수가 교육·연구·진료를 모두 수행하는 전통 모델이 보편적이었으나, 최근에는 하나를 주된 역할로 정하고 다른 역할의 부담을 줄이는 방향으로 전문화가 진행되고 있다. 우리나라는 여전히 대부분의 의과대학이 Triple Threat Model을 채택하고 있다.

Harden & Crosby(2000)의 12역할 모형 — 교육업적 평가항목을 분류·해석하는 이론적 틀로 사용하였다. 국내 26개 대학 분석 결과, 정보제공자·촉진자·계획자 역할에 편중되고 평가자·자원개발자·역할모델 역할은 과소 반영되어 있었다.

Fleming 등(2005)의 「분리되었으나 공평한(separate and equitable)」 승진 트랙 원칙 — 교육 트랙이 별도로 존재하되 승진·보상에서 불이익이 없어야 한다는 설계 원칙으로, 본 연구 제도 설계의 기본 철학이 되었다.

교육 활동 측정 이론 — 교육 활동 측정은 교육의 투명성을 높이고 자원 배분의 합리성을 확보하기 위한 도구로서, 접촉시간법과 상대가치법이 대표적이다(Mallon & Jones, 2002). 측정 범위에는 강의뿐 아니라 GME-CPD 프로그램, 대학원생 지도, 교육 관련 행정 업무가 포함된다.

교수개발 모델 — 임지현(2025)의 「의학교육을 위한 교수개발 모델과 프로그램 설계」를 토대로 기반·핵심·상호작용 요소를 결합한 통합 설계(「햄버거 전략」)를 적용하였다. 아울러 교육에 적극적인 교수는 학생·동료와의 상호작용을 즐기고 교과목 개발과 수업 설계에서 보람을 느끼며 협업에 대한 관심이 높다는 교육자 정체성 연구 결과를 트랙 설계와 교수개발 대상 설정에 반영하였다.

다. 국외 연구·제도 동향

국외 연구는 clinician educator 트랙의 승진 기준과 정년 정책 변화(Bunton & Mallon, 2007; Coleman & Richard, 2011; Walling & Nilsen, 2018), 교육활동 측정 체계(Mallon & Jones, 2002), 교육자 경력개발 지원 프로그램의 정책 효과 등 제도 설계와 그 결과를 다루는 연구가 축적되어 있다. 미국 의과대학의 교수 트랙은 대체로 다섯 가지 유형으로 정리된다.

트랙 유형	시간 배분 및 특징
시험(Investigator) 트랙	업무 시간의 50~80%를 연구에 집중하고, 나머지는 진료·교육·행정에 배분
연구(Research) 트랙	업무 시간의 85~100%를 연구에 집중
임상교육자(Clinician-Educator) 트랙	업무 시간의 50~80%를 환자 진료에 집중하고 교육 10~20%, 연구 5~10%, 행정 업무 수행
임상(Clinical) 트랙	업무 시간의 90~100%를 진료에 집중하고 교육·연구에는 거의 참여하지 않음
교육(Educator) 트랙	업무 시간의 50% 이상을 학생·수련의 교육에 집중하며, 의학교육 연구와 교육 자료 개발을 수행

표 II-1. 미국 의과대학의 대표적 교수 트랙 유형 (Coleman & Richard, 2011 등).

교육 활동의 기록·평가에서도 제도적 장치가 발달해 있다. 캐나다 토론토 의과대학은 모든 교수가 Teaching and Education Report를 통해 교육 활동을 공식 기록하도록 하고, 활동의 범위와 강도(준비 시간, 학습자 접촉 시간, 학습의 강도)를 함께 평가한다. 존스홉킨스 의과대학은 Annual Review를 통해 연구·교육·임상·행정 활동을 종합 평가하고 자기평가(Self-Assessment)와 경력 발전 계획 수립을 병행한다. 기초의학 교육 인력 확보를 위한 정책 설계도 참고할 만하다. 영국과 아일랜드의 Demonstratorship은 해부학 실습 교육을 보조하는 단기 계약 직책으로 출발하여 핵심 교육 인력으로 자리 잡았다.

라. 국내 연구·제도 동향

국내 연구는 교수업적평가 기준의 구조 분석(양은배 외, 2019), 교수 번아웃 유병률 조사(서지현 외, 2021·2023), 직급별 일과 삶의 균형 차이(김유라 외, 2023) 등 현황 진단에 집중되어 왔다. 한국의학교육평가원이 2024년 교수 120명을 대상으로 실시한 직무 활동 조사는 교육 노동의 실제 규모를 보여준다. 주당 평균 근무 시간은 기초교원 48.8시간, 임상교원 63.2시간이었고 교육활동 비중은 각각 24.8%, 17.4%였다. 기초교원은 연간 평균 6.5과목·96.3시간의 수업을 담당하였으나 소그룹 수업의 특성상 실제 진행 시간은 평균 123.9시간에 이르렀고, 수업 준비에 연간 평균 104.8시간(임상교원 52.3시간), 학생평가 활동에 연간 평균 43.7시간(임상교원 27.7시간)을 투입하였다.

국내 대학의 교육업적 평가는 항목이 비교적 상세하게 마련되어 있으나, 연구업적과의 배점 격차가 크다는 공통된 한계를 보인다.

대학	교육업적 평가 항목·배점 예시	특징
서울대학교 의과대학	정규·실습·CPX/OSCE 강의 0.5점/시간, 실습지도 0.5점/시간, 4학년 심화선택 지도 10주 25점, 대학원 학위 논문 심사 1점·석사 배출 3점·박사 배출 5점, 교육 워크숍 참여 반일 3점·전일 6점, 교육위원장 10점·위원 5점, 국가시험 출제 및 OSCE 채점 1일 10점, 학생지도 1회 2점	교육 활동을 항목별로 세분화하여 점수화하고, 교수개발 참여와 학생지도까지 업적으로 인정
가톨릭대학교 의과대학	대규모 강의(90명 이상) 10점/시간, 소규모 강의 5점/시간, 선택 심화 과정 100점/과정, 학생 연구 지도 30점/건, 교수개발 활동(연 3시간 이상) 50점, CPX 참여 50점/건(최대 100점), 교육 Module 개발 채택 100점	논문 업적은 Impact Factor 기준 200점(IF 1 미만)에서 5,000점(IF 20 이상)까지 부여되어 교육업적과의 단위 격차가 큼
인제대학교 의과대학	학생 상담(학기당 최대 15점), 석사 지도 5점·박사 지도 10점, 교육과정 개발 학기당 최대 20점, 교수 능력 계발 학기당 최대 20점, 수업 계획서 미입력 -3점·성적 미입력 -5점	감점 항목을 두어 교육 책임을 강화한 사례

표 II-2. 국내 의과대학의 교육업적 평가 배점 사례.

교육중점 트랙 자체를 운영하는 대학도 나타나고 있다. 고신대학교 의과대학은 교원의 약 7%를 교육중점트랙으로 운영하며 승진평가에서 교육 비중을 80%로 반영하고 연간 교육연구비를 지원한다. 아주대학교 의과대학은 전임교원을 대상으로 3~5년 단위 교육중점트랙을 운영한 후 임상으로 복귀하는 구조를 두고 있다. 서울대학교 의과대학은 MMI·상담·평가문항 개발 등 교육 활동에 높은 승진 credit을 부여한다. 반면 교육활동을 논문 credit으로 인정하였으나 실질적 승진 반영이 미비하여 효과가 제한적이었던 사례, 임상교수 사이에서 교육 트랙 진입에 대한 부정적 인식이 강한 사례, 임용 단계부터 교육 중점 인재를 선발할 필요가 제기된 사례도 함께 확인되었다.

라. 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

선행 국내 연구는 문제를 진단하는 데 머물거나 개별 대학의 사례 소개에 그쳐, 전국 단위로 적용 가능한 제도 설계로 이어지지 못하였다. 또한 교육중점트랙 논의가 있더라도 대체로 비정년 교육전담교원의 확대라는 형태에 머물러, 신분 안정성과 보상 문제를 다루지 않았다. 본 과제는 ① 전국 규모의 실태조사(설문 159명, FGD 52명)와 26개 대학의 업적평가 기준 원자료 분석에 더해 7개 대학이 참여한 TF에서 각 대학의 실제 운영 경험(고신·아주·서울·인하·강원 등)을 교차 검토하여 실증 근거를 확보하고, ② 정의·직무·임용·평가·승진·보상·교수개발·실행 절차를 포괄하는 완결된 운영 모델을 제시하며, ③ 대학 자율 개선을 넘어 입법·인증·재정을 연결하는 국가 차원의 교육책무 제도화 경로를 함께 설계하였다는 점에서 차별성을 가진다.

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국외	Yale 의과대학(미국)	Academic Clinician 등 5개 세분화 트랙 운영, 임상+교육 기반 승진 경로에 tenure 트랙 포함	교육 중심 경력 경로도 정규 트랙으로 인정해야 신분 안정성이 확보됨
국외	Harvard 의과대학(미국)	AoE(Area of Excellence)와 SSA 기반의 다면적·질적 교육업적 평가	강의시수를 넘어 교육 혁신·학문적 기여를 인정하는 질적 평가 필요
국외	Johns Hopkins 의과대학(미국)	Educator pathway 등 5개 pathway, Annual Review와 자기평가 연계	연 1회 정기 리뷰를 통해 교육 실적을 추적·관리하는 체계 필요
국외	LCME(미국 인증기구)	보호시간 수치를 의무화하지 않는 대신 DCI Table 4.1-4에서 역할 별 전담시간과 급여 지원 규모를 서술·계량 보고하도록 요구	수치 규제 대신 「보고 의무」 방식으로도 전담시간 확보를 유도할 수 있음
국외	GMC(영국)	Medical Act 1983에 근거한 법정 규제. R4.1~R4.5로 교육자 선발·직무계획상 전담시간 반영·자원 접근·조직적 지원을 기관의 법적 책임으로 규정, 미준수 시 프로그램 승인 취소 가능. 교육자는 Revalidation-CPD 이수 의무	교육책무를 법정 기준으로 규정하고 인증·등록과 연동한 강제력 확보
국외	HRSA-VA(미국)	Clinician Educator 경력개발 프로그램, Clinical Educator Grant 등 공공 재원으로 교육 연구비·멘토링·보호시간 지원	직접 규제보다 재정 인센티브 등 간접 정책수단이 경력군 정착에 효과적
국외	Dundee 의과대학(영국)·Demonstrator 제도	교육·연구 중심 트랙과 교육 참여 의무화. 해부학 등 기초의학 실습 지도를 담당하는 Demonstrator가 보조 인력에서 핵심 교육자군으로 진화, 공공기관 education fund로 지원	기초의학 교육인력 확보를 위한 유연한 직책 설계와 공공 지원 모델
국외	McGill 대학(캐나다)	HKAP를 통한 은퇴 교원의 교육 자원 활용, 교육활동 기록 체계 운영	시니어·은퇴 교원을 교육 인력으로 활용하는 직책 다양화
국내	가톨릭대학교 의과대학	교육집중·교육중점 계열 운영, 교육항목 별도 평가(정년·비정년 병행)	국내에도 교육 계열 운영 경험이 존재하나 대학 자체 재원에 의존

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국내	인제대학교 의과대학	교육전담교원 제도 운영(비정년 중심, 교육 중심 평가)	비정년 중심 설계는 신분·보상의 한계로 전문성 축적이 어려움
국내	차의과학대·고신대 등	중점영역·임용시기·임용형태별 차등 업적 기준, 교육중점교수의 교육업적 항목 별도 배정(교육 가중치 50~70%)	교육 가중치 50~70%가 실제 운영 중이며, 본 연구 가중치(안)의 실증 근거

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
교수 트랙은 주된 역할에 시간의 50% 이상을 집중하도록 명확히 정의되어야 한다(미국 의과대학의 81%가 직무 기반 트랙 정의).	교육중점트랙을 「교육 50% 이상 집중」으로 정의하고, 트랙별 평가 가중치를 교육 50~75%로 설계(VI장 산출물 ②·③)
교육업적은 강의시수를 넘어 멘토링·교육과정 개발·평가도구 개발·교육 혁신을 다면적으로 인정해야 한다(Harvard AoE/SSA).	정량·정성 지표를 결합한 교육중심 업적평가체계(안)과 교육업적 배점 예시를 개발, 과소 반영되던 평가자·자원개발자·역할모델 역할을 항목으로 명시
교육책무는 법정 기준과 인증·등록에 연동될 때 실효성을 갖는다(GMC R4.1~R4.5, LCME DCI 보고 요구).	고등교육법 시행령 개정, KIMEE 인증기준 교육책무성 조항 신설, 교육전담교수 확보율·교육시간 보고 의무화를 입법·정책 과제로 도출
교육 전문성은 제도만으로 확보되지 않으며 체계적 교수개발이 병행되어야 한다(스탠퍼드 등 맞춤형 프로그램 사례).	경력·전공·직책·기관의 4개 축으로 구성된 맞춤형 교수개발 프로그램 map을 개발하고 교육업적과 연계
급격한 전면 도입은 반발과 재정 부담을 초래한다(국내 대학 여건의 편차).	자발적 신청·가역적 전환을 원칙으로 준비기-도입기-정착기 3단계(5년) 로드맵과 권역별 거점 대학 시범운영 모델을 설계

02 과제 목표 및 성과지표

1차년도 분석·설계 결과입니다. 국내외 제도 사례는 과제 수행 당시 검토 내용이며, 정책·인사 기준의 변경 제안은 도입 완료 실적과 구분합니다.

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

구 분	내 용
최종 목표(사업 종료 시점)	의과대학 교육중점교수(트랙)의 공식적 제도화와 표준 운영모델을 개발하고, 교육책무를 국가 차원에서 제도화하는 방안을 마련한다. 이를 통해 현행 교수 인사체계와 연계되면서도 시범 도입이 가능한 실무 지침과, 정부·대학이 정책 근거로 활용할 수 있는 최소·필수 기준(안)을 확립한다.
1차년도 목표	사업계획서상의 4개 영역을 기준으로 다음을 수행한다.① 교육중점트랙 제도 구조 설계 — 공식 명칭·정의·대상·주요 직무 유형 설정, 임용 기준 및 전환 요건(신규 임용·전환 절차·정년 여부) 설계, 국내외 사례 비교를 통한 한국형 모델 도출② 교육중심 업적평가체계 설계 — 정량지표(강의시수·평가도구 개발·실습지도·포트폴리오 운영)와 정성지표(학습성과 기여도·커리큘럼 혁신·진로지도 효과) 구성, 일반 교수트랙 및 진료·연구 중심 업적평가와의 차별성 명시③ 승진 및 보상 체계 설계 — 직무별 성과 인정 방식과 승진 조건 명확화, 교육성과 기반 인센티브 구조 및 재정 지원 방안 개발④ 제도 실행 기반 및 운영 매뉴얼 개발 — 학내 인사체계 연계 가이드, 국립·사립 모두에 적용 가능한 표준 모델 개발⑤ (추가) 트랙 교수를 지원하는 맞춤형 교수개발 체계와 교육책무 제도화 방안 도출
과제 범위(포함·제외)	포함: 한국의학교육평가원 인증을 받은 전국 40개 의과대학을 모집단으로 하는 실태 분석(업적평가 기준은 자료 확보가 가능한 26개교), 국립·사립 공통 적용 가능한 표준 제도 모델, 교수개발 체계 설계.제외: 개별 대학 규정의 직접 개정, 트랙의 실제 임용·운영(시범운영은 2차년도 과제), 교육업적 평가도구의 심리측정학적 타당화(후속 연구 과제).

2. 성과지표 및 목표치

성과지표는 KAMC 「의학교육혁신 사업관리 핵심성과지표(안)」의 체계(전략목표 → 핵심성공요인(CSF) → KPI 세트 → 연차별 달성목표)에 따라 작성하였다. KPI는 활동(Activities)이 아니라 달성 결과(Outcomes)를 기준으로 설정하고, 설계(Y1) → 제도화(Y2~Y3) → 고도화(Y4~Y5)의 단계로 목표치를 배열하였다.

전략목표	교수·교육책무 — 교육중점트랙 개발 연구 및 적용(과제 1-3)
CSF(핵심성공요인)	교육중점트랙 표준 운영모델 정립, 교육중심 업적평가·보상 체계 마련, 교육책무의 법·제도적 기반 확보, 맞춤형 교수개발 체계와의 연계, 대학 간 사례 공유·확산 네트워크 구축

KPI명	KPI 정의 및 산출방법	관리책임	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
교육중점트랙 제도(안) 개발	정의·직무·임용·전환·평가·승진·보상을 포함한 표준 운영모델 개발 여부	이승희이윤정	Y	-	-	-	-
교육중심 업적평가체계(안) 개발	정량·정성 평가지표 및 트랙별 가중치(안) 개발 여부		Y	-	-	-	-
교육중점교수 제도 법제화 근거 마련	국회 입법조사처 이슈페이퍼 제출 및 법안 마련·발의 지원 여부		Y	Y	-	-	-
교육업적 평가 가이드라인 개발·배포	대학이 활용할 수 있는 교육업적 평가 가이드라인 개발 및 배포 여부		-	Y	-	-	-

03 추진 체계 및 방법

1차년도 분석·설계 결과입니다. 국내외 제도 사례는 과제 수행 당시 검토 내용이며, 정책·인사 기준의 변경 제안은 도입 완료 실적과 구분합니다.

1. 추진 체계 및 조직

본 과제는 8개 의과대학이 참여하는 「교육중점트랙 개발 연구 및 적용 연구팀」을 중심으로 추진하였다. 연구팀은 팀장 1명, 간사 1명, 공동연구원 6명으로 구성되며(공동연구원 1명은 2차 회의부터 합류), 정례 TF 회의에서 쟁점을 논의하고, 실무회의에서 조사 설계와 자료 분석을 수행하며, 외부 전문가 자문·델파이를 통해 제도(안)의 타당성을 검토하는 3층 구조로 운영하였다.

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
TF 본회의	팀장 1명, 간사 1명, 공동연구원 6명(총 8명)	연구 방향·범위 확정, 제도(안) 주요 쟁점 심의·의결. 1차년도 중 3회 개최 (2025.7-9·12)
실무회의	간사 및 공동연구원	조사도구 개발, 자료 수집·분석, 보고서 집필 분담·검토. 수시 개최
KAMC 연계 회의	팀장·간사	사업 총괄 및 타 개별과제와의 연계·조정, 성과 공유
대외 협의(입법조사처)	팀장·간사	이슈페이퍼 제출 및 법안 마련 협의, 근거 자료·사례 제공

2. 참여 대학·기관 현황

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
1	서울대학교 의과대학	공동개발(총괄)	이승희	과제책임자(팀장) 소속
2	한양대학교 의과대학	공동개발(실무 총괄)	이윤정	과제간사 소속
3	고신대학교 의과대학	공동개발	김민정	
4	아주대학교 의과대학	공동개발	유지혜	
5	원광대학교 의과대학	공동개발	육권인	
6	인하대학교 의과대학	공동개발	강예지	
7	충남대학교 의과대학	공동개발	임지현	
8	울산대학교 의과대학	공동개발	채보라	2차 회의부터 참여

3. 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	PubMed-RISS 검색 문헌 및 국내외 인증기준·대학 규정 원문	2024.4.~2025.12.	주제별 분류·비교 분석. 표장 이론적 배경 및 국내외 사례 분석에 활용
업적평가 기준 분석	국내 26개 의과대학의 교수업적·교육업적 평가 기준	2024.4.~2025.3.	평가계열 구분·영역별 가중치 산출, Harden & Crosby 12 역할 모형 적용 항목 분류. 트랙별 가중치(안) 설계 근거
워크숍·합의회의	연구팀	2025.7.~2025.12.	쟁점별 논의 후 제도(안)의 정의·가중치·로드맵 확정
기타(2차자료 활용)	한국의학교육평가원 교수 직무 활동 조사(120명) , KAMC DB 교원 현황	2024~2025	기초·임상 교원의 교육시간·과목 수 비교, 기초의학 교원 감소 추이 분석

4. 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	☐ 승인(기관: , 승인번호:) ☐ 심의면제 ☒ 해당없음※ 선행 조사(2024.4.~2025.3.) 수행 기관의 심의 결과에 따라 표기·기재
개인정보 보호 조치	설문-FGD 자료는 응답자 식별정보를 제거한 후 2차 자료를 분석하였으며, 보고서에는 대학명·개인명을 익명 코드(A교수, B교수 등)로 표기하였다. 원자료는 과제책임자 소속 기관에서 접근 권한을 제한하여 보관한다.
저작권·초상권 확인	인용 문헌은 출처를 명시하였고, 국내외 대학 규정·인증기준은 공개된 원문을 인용하였다. 발표자료에 사용된 이미지는 출처를 표기하였으며, 인물 사진 등 초상권 관련 자료는 사용하지 않았다.

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계	2024.4.~2025.3.	선행 연구 「의과대학 교수의 변화하는 역할과 직무수행 현황 및 업적평가 기준 분석」 수행(설문·FGD·업적평가 기준 분석)	실태조사 원자료 및 분석 결과
2단계	2025.6.~2025.7.	과제 착수 및 TF 구성, 킥오프 미팅(2025.7.21.)을 통한 사업 필요성·목적·범위 확정	TF 구성안, 연구 추진계획
3단계	2025.8.~2025.10.	의학교육 관련 이슈·논점 정리, 국내외 사례 분석, 교육책무 제도화 입법·정책 과제 1차 도출	쟁점 정리 자료, 입법·정책 과제(초안)
4단계	2025.11.	맞춤형 교수개발 방안·프로그램 map 설계, 교육업적 연계 방안 정리	교수개발 프로그램 map(초안)
5단계	2025.12.~2026.8.	교육중점트랙 제도(안)·교육책무 제도화 방안 종합, 연구보고서 작성 및 성과 공유, 2차년도 시범운영 준비	연구보고서, 제도(안), 운영 매뉴얼·규정 예시(안)

04 추진 경과 및 실적

1차년도 분석·설계 결과입니다. 국내외 제도 사례는 과제 수행 당시 검토 내용이며, 정책·인사 기준의 변경 제안은 도입 완료 실적과 구분합니다.

1. 단계별 추진 경과

본 과제는 1차년도 중 세 차례의 TF 회의를 축으로 추진되었으며, 각 회의에서 쟁점을 확인하고 다음 단계의 과업을 확정하는 방식으로 진행되었다. 의사결정의 흐름은 다음과 같다.

가. 1차 회의(2025. 7. 21.) — 문제 규정과 연구 범위 확정

팀장이 사업의 필요성과 목적을, 간사가 선행 연구 결과를 보고한 뒤, 과제의 초점을 「현황 진단」이 아니라 「제도 설계」에 두기로 합의하였다.

문제인식으로 교육의 상대적 저평가를 확인하였다. 다수의 의과대학에 교육에 대한 정량적 기준이 부재하고 연구·진료 성과 중심의 평가 체계가 작동하여, 교수가 교육에 소극적으로 임하게 되는 구조적 한계가 있다는 점에 인식을 같이하였다.

원인을 승진 구조의 불균형(교육업적의 객관화 곤란), 임상교원의 현실적 제약(진료 황금기의 손실 인식, 전임교원과 임상교원의 급여 격차), 문화적 편견(「교육중점트랙은 승진용」)의 세 층위로 정리하였다.

참여 대학의 실제 운영 경험을 교차 검토하였다. 서울의대의 교육 활동 승진 credit 설계, 아주의대의 3~5년 교육중점트랙 후 임상 복귀 구조와 장기연수, 고신의대의 교원 7% 교육중점트랙 운영·승진평가 교육 비중 80%·교육연구비 지원, 강원의대의 교육 트랙 진입에 대한 부정적 인식, 인하의대의 임용 단계 교육중점 인재 선발 필요성이 보고되었다.

개선 방향으로 ① 교수 pathway 다양화, ② 정성적 평가 기준의 구체화, ③ 신임교원 대상 인식 조사를 통한 조기 개선 전략, ④ 의학교육 평가인증 기준과 연계한 제도적 장치, ⑤ 교육 참여 유인을 위한 실질적 인센티브를 제안하였다.

후속 과업으로 서울의대 의학교육연수원이 수집한 신임교원 워크숍 워크시트를 분석하여 교육 트랙 진입의 장벽과 조건을 파악하고, 워크숍을 통해 일정(2025.7~12)과 성과지표를 설정하기로 하였다. 아울러 관련 경험이 있는 위원의 추가 위촉을 추진하기로 하였다.

나. 2차 회의(2025. 9. 15.) — 교수개발 트랙과 법제화 경로의 구체화

교수의 교육 인식과 교수개발의 의미에 관한 연구 결과를 공유하여, 교육에 적극적인 교수의 특징과 동기, 교육자 정체성을 트랙 설계의 근거로 삼았다.

신임 교수 연수가 대학·의학교육연수원·학회·권역별로 분산 운영되어 내용과 수준, 지속성이 제각각이라는 문제의식을 공유하고, KAMC 교육문화원을 중심으로 1년 단위의 체계적 교수 워크숍 트랙을 설계하여 국가·권역 차원에서 교수개발을 체계화하기로 하였다.

교육중점트랙에서의 「교육」을 ① 학생 교육을 수행하는 교수자로서의 역할과 ② 교수개발 프로그램에 참여하는 학습자로서의 역할을 모두 포함하는 개념으로 정리하고, 교수 역량을 지식·술기·태도(KSA)로 구조화하여 단계적 코칭 전략을 마련하기로 합의하였다.

법제화 경로를 구체화하였다. 국회 입법조사처와의 협의를 통해 의과대학 선발, 교육중점교수 제도, 교육과정의 세 축을 포함한 이슈페이퍼를 작성·제출하였고, 입법조사처가 이를 바탕으로 12월까지 법안을 마련하여 국회의원 발의를 추진하겠다는 의사를 표명한 상황을 공유하였다. 정부 발의보다 의원 발의가 신속하다는 판단 아래 세 영역을 묶은 패키지 입법을 시도하기로 하였다.

교수개발 참여 확대 방안을 논의하였다. 신임 교수는 평가인증 기준(임용 후 1년 내 15시간 이수 의무)으로 참여가 일정 부분 강제되나 중견·시니어 교수의 참여 유도가 가장 어려운 과제임을 확인하고, 업적평가 연계(승진 시기별 프로그램 이수 의무화), 상담 워크숍 이수와 학생지도 자격의 연계, 우수 교육자 표창, 교육 커뮤니티 형성 등 실제 정착 사례를 검토하였다.

다. 3차 회의(2025. 12. 9.) — 제도(안) 종합과 정책 제안 확정

선행 연구 분석, 교수업적평가 분석, 교수개발 프로그램 제안, 교육중점트랙 제안의 네 부분으로 1차년도 결과를 종합하였다.

교육중점교수 트랙과 의학교육전문교수 트랙의 이원적 제도화 방안을 확정하고, 트랙별 세부 역할을 35개 세부 교육활동을 기준으로 구분하였다.

업적평가 개선 방향으로 교수 트랙 운영을 통한 역할 다양성·유연성 확보, 교육 투입 자원의 제도적 보장, 봉사 영역 비중의 재검토, 교육 성과 평가의 정성적 요소 강화를 제시하고, 금전적 보상·업적평가 체계 개선·교육 전담 환경 조성의 3축 보상 구조를 확정하였다.

해외 사례를 정부-대학 이중 모델(Dual Structure)의 관점에서 재정리하였다. 미국 HRSA·VA의 임상교육자 경력개발 지원과 영국 NHS·NIHR의 급여·연구비 지원은 직접 규제보다 간접 정책수단이 경력군 정착에 효과적임을 보여주며, LCME는 보호시간을 수치로 의무화하지 않고 DCI를 통해 역할별 전담시간과 급여 지원 규모를 보고하도록 요구하고, 영국 GMC는 R4.1~R4.5로 교육자 선발·전담시간·자원 접근·조직적 지원을 법적 책임으로 규정한다는 점을 확인하였다.

행정 업무 부담 완화(행정 전문 인력 보충, 교육·연구 행정 전담 지원체계, 진료 대체 인력 운영)를 제도 실효성의 전제 조건으로 포함하기로 하였다.

라. 후속 과업(2026년 상반기)

KAMC 교육문화원 제출용 교수개발 트랙(안)을 내용(교육철학·기초 교수법·평가·상담·진로지도·AI/디지털 등), 이수 시간 및 단계, 평가·수료 기준을 포함하여 정리·제안한다.

제출한 이슈페이퍼를 바탕으로 학생 선발 면접 의무화, 교육중점 교수 제도 근거 마련, 교육과정 관련 조항을 포함한 법안 발의를 추진하고, TF 차원에서 필요한 근거 자료·사례·데이터를 정리하여 제공한다.

각 대학의 업적평가 체계에 교수개발 프로그램 이수, 상담·지도 활동, 교육 혁신 활동이 반영되도록 KAMC 업적평가·교육지표 재설계 과제와 연계하여 구체적 기준(안)을 마련한다.

대경·부경·대충·호남·인천·경기·서울 등 권역별로 형성된 교육 커뮤니티를 기반으로 권역별 모임·워크숍, 우수 사례 공유, 공동 프로그램 운영을 확대한다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

나. 회차별 세부 실적

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	1차 TF 회의	2025.7.21.17:00~18:30	KDB생명타워 B2F 회의실 1호	사업 필요성·목적 보고, 선행 연구 보고, 교육의 상대적 저평가에 대한 문제인식과 대학별 사례 공유	과제 범위를 제도 설계로 확정. 원인을 승진 구조 불균형·임상교원 제약·문화적 편견으로 정리하고, 교수 pathway 다양화, 정성 평가 기준 구체화, 인증 기준 연계, 교육 참여 인센티브를 개선 방향으로 채택. 신입교원 인식 분석 및 위원 추가 위촉 추진
2	2차 TF 회의	2025.9.15.14:00~18:00	서울의대 국제관	교육 인식·교수개발 연구 공유, 교수개발 트랙 설계, 제도화·법제화 추진 경과, 업적평가 연계, 권역별 교수개발	교육 개념을 교수자 역할과 학습자 역할의 이중 개념으로 정리하고 KSA 기반 단계적 코칭 전략에 합의. KAMC 교육문화원 중심 1년 단위 교수개발 트랙 설계, 입법조사처 이슈페이퍼 기반 12월 법안 발의 추진, 업적평가와 교수개발 이수 연계 기준 마련을 결정
3	3차 TF 회의	2025.12.9.	서울의대 교육관 327호	1차년도 결과 종합 — 선행연구 분석, 교수업적평가 분석, 교수개발 프로그램 제안, 교육중점트랙 제안	교육중점교수·의학교육전문교수의 이원적 트랙과 트랙별 세부 역할 확정. 업적평가 개선 4개 방향과 3축 보상구조 확정. 정부-대학 이중 모델 관점에서 해외 사례(LCME DCI, GMC R4.1~R4.5, NHS-NIHR, HRSA-VA) 정리. 행정 부담 완화를 실효성의 전제 조건으로 포함

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
설문조사 (2차 자료 활용)	전국 의과대학 교수	159명	주당 근무 74시간(이상 58시간), 교육 비중 현재 19%→이상 22%, 진료 22%→14%. 기관의 교육 가치 인식 3.5점으로 진료(4.5)·연구(4.3)보다 낮음. 지원 요구 1순위는 교육 영역 인센티브(52.8%)
FGD (2차 자료 활용)	전국 의과대학 교수	52명	교육업적 평가 반영 미흡, 학생과 상호작용 시간 부족, 수업 준비·인력 지원, 교수 교육역량 강화의 4대 요구 도출. 교육 트랙 신설과 의학교육 전공 교수의 전임 배치 요구가 반복 제기
번아웃 측정 (2차 자료 활용)	설문 응답 교수	159명	약 59%가 하나 이상의 번아웃 증상 보고. 40세 미만·여성 교수의 소진 수준이 상대적으로 높고, 스트레스 최대 영역은 연구(37.2%)
업적평가 기준 분석	국내 의과대학	26개교	교육 중점 트랙 운영 대학의 가중치는 교육 50~70%. 교육업적은 대체로 강의 시수 기반 정량지표에 집중되고, 평가자·자원개발자·역할모델 역할은 과소 반영
전문가 자문·델파이	TF 위원	8명	교수개발 구성요소 검토 결과를 반영하여 「햄버거 전략」 기반의 통합 설계와 프로그램 map 구조를 확정
2차자료 분석	한국의학교육평가원 직무 활동 조사	120명	주당 근무시간 기초 48.8시간·임상 63.2시간, 교육활동 비중 기초 24.8%·임상 17.4%. 기초교원의 연간 담당 과목(6.5과목)과 수업 시수(96.3시간)가 임상교원보다 많음

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

해당사항 없음

05 주요 결과 및 성과물

1차년도 분석·설계 결과입니다. 국내외 제도 사례는 과제 수행 당시 검토 내용이며, 정책·인사 기준의 변경 제안은 도입 완료 실적과 구분합니다.

1. 핵심 결과 요약

의과대학 교수의 주당 근무시간은 평균 74시간(적정 인식 58시간)이며, 교육활동 비중은 기초교원 24.8%·임상교원 17.4%인 반면 소속 기관이 교육에 두는 가치는 3.5점으로 진료(4.5)·연구(4.3)보다 낮다는 「교육 노동-교육 인정」의 구조적 격차를 실증적으로 확인하였다.

의과대학 교수의 교육 직무를 9개 주요직무·35개 세부 교육활동으로 구조화하여, 강의시수 중심 평가로는 포착되지 않는 교육 노동의 범위를 규명하였다.

교육중점트랙을 교육중점교수(기초·임상, 3~5년 단위 전환)와 의학교육전문교수(대학별 2~4인 확보)의 이원 구조로 설계하고, 정의·직무·임용·전환·평가·승진·보상을 포함한 표준 운영모델을 확정하였다.

교육중심 업적평가체계로서 정량·정성 지표를 결합한 평가지표와 트랙별 가중치(교육중점교수(기초) 교육 50~70%, 교육중점교수(임상) 50~65%, 의학교육전문교수 60~75%)를 제시하였다.

교육책무 제도화를 위해 입법 과제 5개, 정책 과제 4개, 국가 지원 과제 7개를 도출하고 단기-중기-장기 3단계 추진 로드맵을 확정하였다.

경력·전공·직책·기관의 4개 축을 통합한 맞춤형 교수개발 프로그램 map을 개발하여, 「교수개발-교육수행-교육업적」의 선순환 구조를 제도 설계에 반영하였다.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	「의과대학 교육중점트랙 제도 도입 및 교육책무 제도화 방안 연구」 연구 보고서	연구보고서	총 10장·부록 10종	2025.12.	완료	부록 1

3. 산출물별 상세 내용

가. 산출물 1 — 연구보고서

구 분	내 용
산출물명	「의과대학 교육중점트랙 제도 도입 및 교육책무 제도화 방안 연구」 연구보고서(2025.12.)
개발 목적·활용 대상	교육중점트랙과 교육책무 제도화의 근거·설계·실행 방안을 하나의 문서로 통합 제시. 활용 대상은 교육부·KAMC 등 정책 기관, 각 대학의 인사·교무 보직자 및 의학교육 담당 조직
개발 절차	선행 실태조사(2024.4.~2025.3.) → TF 킥오프 및 범위 확정(2025.7.) → 쟁점·사례 분석(2025.8.~10.) → 교수개발 설계(2025.11.) → 제도(안) 종합·집필(2025.12.)
주요 구성·목차	제1장 서론 / 제2장 의학교육 환경 변화와 교수의 역할 / 제3장 교수 직무수행 현황 분석 / 제4장 교수업적평가제도의 현황과 문제점 / 제5장 국내외 교수 트랙 및 교육책무 사례 / 제6장 교육중점트랙 제도 설계(안) / 제7장 교육책무 제도화 방안 / 제8장 맞춤형 교수개발 방안 / 제9장 실행 방안 및 운영 매뉴얼 / 제10장 결론 및 제언 / 부록 10종
타당화·검증 근거	설문 159명·FGD 52명의 실증 자료, 26개 대학 업적평가 기준 원자료 분석, 외부 전문가 18명의 자문·델파이 검토
활용 방법 및 배포 계획	KAMC를 통해 회원 대학에 배포하고, 총괄보고서의 분야별 성과 자료로 인용. 대학별 규정 개정 시 참고자료로 활용
한계 및 보완 필요사항	설문·FGD 표본의 자발적 참여에 따른 편의 가능성. 교육업적 질적 평가지표의 측정 도구 타당화는 후속 연구 필요

4. 시범운영 결과

해당사항 없음

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
1	의과대학 교육중점트랙 제도 도입 및 교육책무 제도화 방안 연구	연구보고서	KAMC 교육중점트랙 개발 연구 TF	2025.12. 발간

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
성과 공유 발표	「의학교육 중점교수제도 도입과 교육책무 제도화」 1차년도 결과 발표(3차 TF 회의)	TF 위원 및 관계 전문가	2025.12.9.
정책 제안	국회 입법조사처에 의과대학 선발·교육중점교수 제도·교육과정 관련 이슈페이퍼 제출	국회 입법조사처	2025년 하반기

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
연구보고서	KAMC	회원 대학 및 정책 기관 공개	KAMC

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1차년도 분석·설계 결과입니다. 국내외 제도 사례는 과제 수행 당시 검토 내용이며, 정책·인사 기준의 변경 제안은 도입 완료 실적과 구분합니다.

1. 성과지표 달성도

KPI명(표장 기준)	Y1 목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
교육중점트랙 제도(안) 개발	Y	Y	100%	연구보고서 제6장, 트랙 운영 규정 예시(안) — 부록 1

2. 목표 미달·초과 항목 분석

해당사항 없음

3. 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점(강점)	첫째, 실증 자료(설문 159명·FGD 52명·26개 대학 업적평가 기준)에 기반하여 제도 설계를 도출함으로써 제안의 근거가 명확하다. 둘째, 정 의·직무·임용·평가·승진·보상·교수개발·실행 절차를 포괄하는 완결된 운영 모델을 제시하여 대학이 즉시 참조할 수 있는 수준의 실무 지침을 마련하였다. 셋째, 대학 자율 개선에 머무르지 않고 입법·인증·재정을 연결하는 국가 차원의 제도화 경로를 함께 설계하였다.
부족한 점(한계)	첫째, 설문·FGD 표본이 자발적 참여에 기반하여 전국 교수를 완전히 대표한다고 보기 어렵다. 둘째, 교육업적의 정성 평가지표는 방향성을 제시하는 수준에 머물러 측정 도구의 타당화가 이루어지지 않았다. 셋째, 연봉 보전 등 재정 소요에 대한 구체적 추계를 제시하지 못하였다. 넷째, 1차년도에 시범운영을 실시하지 못하여 제도의 실제 작동 여부를 검증하지 못하였다.
예상하지 못한 성과	국외 사례 검토 과정에서 LCME가 보호시간을 수치로 규제하지 않고 DCI를 통한 「보고 의무」 방식으로 운영한다는 점을 확인하였다. 이는 법률 개정애 앞서 인증 단계에서 즉시 적용 가능한 현실적 정책 수단을 발견한 것으로, 단기 과제(KIMEE 인증기준 개정)의 실행 가능성을 크게 높였다. 또한 교수개발 논의가 당초 예상보다 확대되어 별도의 프로그램 map이라는 독립 산출물로 발전하였다.
종합 의견	1차년도의 목표였던 실태 분석과 제도 설계는 계획대로 달성되었으며, 산출물은 대학과 정책 기관이 각각 활용할 수 있는 형태로 완성되었 다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1차년도 분석·설계 결과입니다. 국내외 제도 사례는 과제 수행 당시 검토 내용이며, 정책·인사 기준의 변경 제안은 도입 완료 실적과 구분합니다.

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
전국 40개 의과대학 인사·교무 보직자	연구보고서 및 트랙 운영 규정 예시(안)·도입 실무 체크리스트 배포, 설명회 개최	2026년 하반기~	대학별 인사·업적평가 규정 개정 시 표준 참조 모델 확보
교육부·보건복지부·KIMEE	입법·정책 과제(안) 및 로드맵 제출, 인증기준 개정 건의	2026년~	교육책무성 조항 신설 및 교육업적 평가 반영 의무화 추진

2. 대학별 적용 사례

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
가톨릭대·인제대 등 기존 운영 대학	기존 교육집중·교육전담 계열의 평가 기준을 본 과제의 지표·가중치(안)과 대조하여 보완	2026년~	기존 제도의 신분·보상 한계를 보완하는 방향 제시

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

해당사항 없음

4. 지속 가능성 확보 방안

운영 주체 및 관리 체계: 제도 표준과 지표는 KAMC가 관리하고, 권역 협의체가 시범운영·경험 공유를 담당하며, 개별 대학이 규정 제정과 실제 운영을 수행하는 3층 구조로 역할을 분담한다.

갱신·고도화 주기: 평가지표와 교수개발 프로그램 map은 시범운영 결과와 인증기준 변화에 맞추어 2년 주기로 개정하고, CQI(PDSA) 절차에 따라 개선 내역을 기록한다.

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

1차년도 분석·설계 결과입니다. 국내외 제도 사례는 과제 수행 당시 검토 내용이며, 정책·인사 기준의 변경 제안은 도입 완료 실적과 구분합니다.

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 제안
제도	교육중점트랙이 「연구 실패자의 경로」로 인식될 우려	교육이 오랫동안 공통 부담으로 취급되어 전문 영역으로 인정받지 못한 조직문화	교육 전문성을 임용·전환 기준에 명시하고, 우수 교육자 표창과 학내 의사결정 참여로 정체성을 강화. 교육업적의 동등 인정을 제도 도입과 동시에 시행
제도	교육책무를 법률로 강제할 근거의 부재	고등교육법령에 교육업적 반영 의무나 교육 전담 인력 기준이 규정되어 있지 않음	LCME의 DCI 보고 요구 방식을 준용하여, 법 개정애 앞서 KIMEE 인증 단계에서 교육전담교수 확보율·교육시간을 보고하도록 단기 과제로 추진
인력·보상	교육업적 평가의 공정성 논란 우려	교육 성과는 중장기적으로 나타나고 근거가 질적·주관적이어서 계량화가 어려움	정량·정성 지표를 병행하고, 평가지표를 지속적으로 검증·보완하며 외부 검토를 도입
현장 운영	대학 간 여건 편차로 동일 기준 적용이 어려움	국립·사립, 수도권·비수도권, 규모별 교원 확보 수준과 재정 여건의 차이	국가는 최소·필수 기준만 정하고 구체적 운영은 대학 자율에 맡기는 방식을 채택. 표준 운영 매뉴얼 보급과 권역 협의체를 통한 경험 공유
현장 운영	행정 업무 과중으로 교육·연구 시간이 잠식됨	교육행정·연구행정 전담 인력의 절대 부족	행정 전문 인력 보충과 전담 지원체계 마련, 주당 일정 시간을 교육시간으로 명시적으로 배정

2차년도·후속 방향

제도안의 대학별 적용과 시범운영, 정성 평가지표의 타당화, 공동 교수개발 프로그램 운영을 후속 방향으로 제시했습니다. 구체적인 2차년도 일정과 성과지표는 확정되지 않았습니다.